

# Un travailleur autiste dans votre équipe de santé au travail

Pour les infirmiers de santé au travail et le personnel de santé en entreprise — soutenir un adulte actif **autiste**.

## L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un adulte se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Les lieux de travail — open-space, bruit, interruptions constantes, règles non écrites — entraînent du camouflage et un **burnout autistique**, lequel est distinct du stress professionnel ordinaire et de la dépression. En tant qu'infirmier/ère de santé au travail, vous êtes bien placé pour le repérer, le distinguer des problèmes de performance, et négocier les aménagements raisonnables qui permettent à un travailleur capable de rester en bonne santé et en poste.

## Ce que vous pouvez observer — and ce qui se passe réellement

| Vous observez...                                                                                  | Ce qui se passe souvent                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Épuisé, perd des compétences, ne peut pas récupérer après le travail                              | <b>Burnout autistique</b> — distinct du burnout professionnel classique et de la dépression |
| « Tout va bien » en consultation, s'effondre pendant des jours après                              | <b>Camouflage</b> intensif ; une visite de 15 minutes montre rarement le coût réel          |
| Ne signale pas la douleur, les symptômes ou les effets secondaires avant qu'ils ne soient sévères | Différences d' <b>intéroception</b>                                                         |
| Conflits liés à l'open-space, aux réunions, au bureau flexible                                    | Problème d'adéquation avec l'environnement, pas un problème de compétence                   |
| Veut tout par écrit ; évite les appels                                                            | La communication sur un canal unique réduit la charge                                       |

## Essayez ceci

- **Proposez l'outil AASPIRE AHAT** avant la visite et des options **priorité à l'écrit** ; autorisez la présence d'un accompagnateur.
- **Reconnaissez le burnout autistique** et ne le confondez pas avec la dépression ou une « faible résilience ».
- **Négociez des aménagements raisonnables** : espace calme, instructions écrites, moins de réunions, communication asynchrone, attentes définies.
- **Commencez les médicaments à faible dose et titration lente** — des réponses sensorielles/émotionnelles atypiques sont courantes.
- **Documentez les aménagements efficaces** pour qu'ils soient automatiques la prochaine fois.

## Évitez ceci

- Laisser une visite calme et masquée l'emporter sur le récit et l'histoire du patient.
- Traiter le burnout comme une dépression et pousser vers un plan de « retour à la charge complète ».
- Assimiler le fait de « ne pas se plaindre » à « ne pas souffrir ».

## Quand demander plus de soutien

Évaluez la **suicidality** — le burnout y est lié. Traitez les comorbidités (**TDAH/AuDHD, anxiété, dépression, sommeil et troubles GI**). Lorsque le burnout est sévère, validez un retour progressif, une réduction d’heures ou un changement de rôle comme récupération, et non comme une faiblesse.

## Si le travailleur est une femme

Les femmes diagnostiquées tardivement camouflent le plus intensément ; prenez au sérieux un schéma de différence et de surcharge sur toute la vie, même avec une apparence « performante ».

### À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Parties 3.4 & 4) et le brief **Monotropisme**. Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n’est pas un avis médical ni un outil de diagnostic.** Adaptez-le à l’individu.

**Sources clés.** Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Mantzalas et al. (2022); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT. Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.